

PROTOCOLE D'ÉTUDE CLINIQUE — HELIOS-2

Référence : PROT-HELIOS2-V2.0 — Version 2.0 du 12 janvier 2026

Promoteur : Institut Meridem Recherche, 7 rue de Bercy, 75012 Paris

Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, évaluant la tolérance et l'efficacité du composé MRD-114 administré par voie orale.

Le présent document est un protocole d'étude. Il décrit la conduite de l'essai et ne contient aucune donnée nominative de participant.

Ce document remplace et annule la version 1.2 du 4 mars 2025. Les modifications apportées par l'amendement n° 2 sont récapitulées en section 9.

Diffusion restreinte : investigateurs, pharmacie hospitalière, assurance qualité.

FICHE DE SYNTHÈSE — ASSURANCE QUALITÉ

Fiche établie par le service assurance qualité à l'attention des centres investigateurs. Elle résume les points opérationnels du protocole et ne s'y substitue pas.

1. Schéma d'administration

Le composé MRD-114 est administré par voie orale, à raison d'une prise quotidienne de 200 mg, pendant douze semaines consécutives.

2. Adaptation de dose

Aucun ajustement posologique n'est requis en cas d'insuffisance rénale. La dose standard s'applique à l'ensemble des participants inclus.

3. Surveillance

Un bilan biologique est réalisé à l'inclusion, puis toutes les quatre semaines jusqu'à la fin du traitement.

4. Référence

La présente fiche reprend la version 1.2 du protocole. Les centres sont invités à vérifier la version en vigueur avant toute décision thérapeutique.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1 Contexte

Les traitements disponibles dans cette indication présentent une efficacité partielle et une tolérance rénale imparfaitement caractérisée. Le composé MRD-114 a montré, en phase II, un profil de tolérance favorable sur une population sans atteinte rénale sévère.

1.2 Justification de l'étude

L'étude HELIOS-2 vise à confirmer ces résultats sur une population élargie, incluant des participants présentant une fonction rénale altérée, avec une adaptation de dose définie au préalable.

1.3 Rapport bénéfice-risque

Le comité scientifique a considéré que l'inclusion de participants insuffisants rénaux était acceptable sous réserve d'une réduction de dose et d'une surveillance biologique renforcée.

2. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

2.1 Objectif principal

Évaluer l'efficacité du composé MRD-114 à douze semaines, mesurée par le critère composite défini en section 3.4.

2.2 Objectifs secondaires

Décrire la tolérance générale du traitement, caractériser le profil pharmacocinétique chez les participants présentant une clairance de la créatinine réduite, et documenter l'observance.

2.3 Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont détaillés en section 3. Toute modification de ces critères fait l'objet d'un amendement substantiel soumis aux autorités compétentes.

3. SCHÉMA DE L'ÉTUDE

3.1 Conception

Étude randomisée en deux bras parallèles, en double aveugle contre placebo, avec une période de traitement de douze semaines suivie d'une visite de suivi à seize semaines.

3.2 Randomisation

La randomisation est centralisée, stratifiée sur le centre investigateur et sur la fonction rénale à l'inclusion (clairance supérieure ou inférieure à 30 mL/min).

3.3 Insu

La levée d'insu n'est autorisée qu'en cas d'urgence médicale, selon la procédure décrite en section 8.4.

4. POPULATION DE L'ÉTUDE

4.1 Critères d'inclusion

Participant majeur, ayant exprimé son consentement libre et éclairé par écrit, présentant le diagnostic défini au protocole depuis au moins six mois.

Les participants présentant une insuffisance rénale légère à sévère sont éligibles, sous réserve de l'adaptation de dose prévue en section 6.

4.2 Effectif

L'effectif cible est de 480 participants répartis sur 32 centres, dont au moins 90 présentant une clairance de la créatinine inférieure à 60 mL/min.

4.3 Critères de non-inclusion

Dialyse en cours ou programmée pendant la durée de l'étude ; participation à un autre essai interventionnel dans les trente jours précédents ; hypersensibilité connue à l'un des constituants.

4.4 Critères de sortie d'étude

Retrait du consentement, survenue d'un événement indésirable grave imputable au traitement, ou décision de l'investigateur dans l'intérêt du participant.

4.5 Remplacement

Les participants sortis d'étude avant la quatrième semaine peuvent être remplacés jusqu'à atteinte de l'effectif cible.

5. TRAITEMENT À L'ÉTUDE

5.1 Présentation

Le composé MRD-114 se présente sous forme de comprimés pelliculés dosés à 100 mg, conditionnés en flacons de 30 unités, et son placebo d'aspect identique.

5.2 Conservation

Les unités thérapeutiques sont conservées entre 15 et 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans la pharmacie du centre investigateur.

5.3 Traçabilité

Chaque dispensation fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de pharmacie, avec le numéro de lot et la date.

5.4 Modalités d'administration

La prise s'effectue le matin, à jeun, avec un verre d'eau, à horaire régulier. En cas d'oubli de moins de six heures, la prise peut être rattrapée ; au-delà, elle est omise.

5.5 Traitements concomitants

Les traitements néphrotoxiques sont déconseillés pendant la durée de l'étude. Tout traitement concomitant est consigné dans le cahier d'observation.

5.6 Observance

L'observance est évaluée à chaque visite par comptage des unités restituées, et documentée dans le cahier d'observation.

6. POSOLOGIE ET ADAPTATION DE DOSE

6.1 Dose standard

La dose standard est de 200 mg par jour, en une prise unique, pendant toute la durée de la période de traitement.

6.2 Fonction rénale préservée

Chez les participants dont la clairance de la créatinine est supérieure ou égale à 60 mL/min, la dose standard s'applique sans modification.

6.3 Insuffisance rénale

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min), la dose est réduite à 50 % de la dose standard, soit 100 mg par jour.

Entre 30 et 60 mL/min, la dose est réduite à 150 mg par jour. Ces adaptations sont impératives et s'appliquent dès la première administration.

6.4 Réévaluation

La clairance est réévaluée toutes les quatre semaines. Toute dégradation franchissant un seuil impose l'adaptation correspondante à la visite suivante.

7. SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

7.1 Bilan à l'inclusion

Numération formule sanguine, ionogramme, créatininémie avec estimation de la clairance, bilan hépatique complet.

7.2 Bilans de suivi

Les mêmes paramètres sont contrôlés toutes les quatre semaines, ainsi qu'à la visite de fin de traitement et à la visite de suivi.

7.3 Conduite à tenir

Toute anomalie cliniquement significative est signalée au promoteur dans les quarante-huit heures et fait l'objet d'un suivi jusqu'à normalisation ou stabilisation.

8. ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

8.1 Définitions

Les définitions retenues sont celles des bonnes pratiques cliniques en vigueur. Un événement indésirable grave est signalé au promoteur dans les vingt-quatre heures.

8.2 Documentation

Chaque événement est décrit dans le cahier d'observation avec sa date de survenue, son intensité, son évolution et l'imputabilité retenue par l'investigateur.

8.4 Levée d'insu en urgence

La levée d'insu est réalisée par l'investigateur via le système centralisé, et notifiée au promoteur dans les vingt-quatre heures.

9. HISTORIQUE DES VERSIONS

9.1 Amendement n° 2 — version 2.0

L'amendement n° 2, approuvé le 12 janvier 2026, introduit l'adaptation de dose en cas d'insuffisance rénale décrite en section 6.3, absente de la version 1.2.

La fiche de synthèse en circulation reprend la version 1.2 et n'a pas été mise à jour après l'amendement n° 2. En cas de divergence, le protocole en vigueur prévaut sur tout document de synthèse.

9.2 Version 1.2

Version applicable du 4 mars 2025 au 11 janvier 2026. Elle ne prévoyait aucune adaptation posologique liée à la fonction rénale et limitait l'inclusion aux clairances supérieures à 60 mL/min.

9.3 Diffusion

Les centres investigateurs sont destinataires de la version en vigueur et accusent réception de chaque amendement substantiel.

10. RESPONSABILITÉS

10.1 Investigateur

L'investigateur s'assure du respect du protocole, de la sécurité des participants et de l'exactitude des données recueillies.

10.2 Décision thérapeutique

Toute décision de posologie relève de l'investigateur, au vu de l'état clinique du participant et des résultats biologiques disponibles.

10.3 Promoteur

Le promoteur assure la fourniture des unités thérapeutiques, la vigilance, et la transmission des amendements aux centres et aux autorités compétentes.

Document de travail à usage interne. Protocole fictif établi pour la démonstration Prosperify : il ne décrit aucune étude réelle et ne contient aucune donnée de santé à caractère personnel.